Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Facharzt für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und Kopf-Hals-Chirurgie

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

AUFKLÄRUNGS- UND EINWILLIGUNGSBOGEN

Ober- / Unterlidstraffung (Blepharoplastik)

Lidchirurgie

Liebe Patientin, lieber Patient, dieser Bogen soll Ihnen in **einfacher und verständlicher Sprache** erklären, was Sie über den Ihnen empfohlenen Eingriff wissen sollten. Er soll Ihnen keine Angst machen, sondern Ihnen helfen, Ihre Entscheidung **frei und gut informiert** zu treffen.

Bitte lesen Sie diesen Bogen in Ruhe durch. Fragen Sie Ihren Arzt nach allem, was Sie nicht verstehen. Ihr Arzt wird Ihnen außerdem mündlich die Risiken erläutern, die speziell in Ihrer Situation bestehen. Ob Sie Ihre Einwilligung geben oder nicht, ist allein Ihr Recht.

ANGABEN ZU PATIENT/IN UND EINGRIFF

Vor- und Nachname: _____ Geburtsdatum: _____

Reisepass- / Ausweisnummer: _____ Akten- / Protokollnummer: _____

Telefon: _____ Datum der Aufklärung: _____

Geplantes Datum des Eingriffs: _____

Bogen erstmals an Patient/in übermittelt (Datum / E-Mail, WhatsApp, persönlich): _____

Durchführender und aufklärender Arzt: **Op. Dr. Murat Ayata**

Krankenhaus / Einrichtung, in der der Eingriff durchgeführt wird: _____

Geplanter Bereich: ☐ Oberlider ☐ Unterlider ☐ Ober- und Unterlider

Technik am Unterlid: ☐ Transkonjunktival ☐ Subziliar (unterhalb der Wimpern) ☐ Nicht zutreffend _____

Zusätzliche Eingriffe: ☐ Fettumverlagerung ☐ Kanthopexie / Kanthoplastik (Lidstützung) ☐ Keine _____

Indikation: ☐ Ästhetisch ☐ Funktionell (eingeschränktes Gesichtsfeld) ☐ Beides _____

Anliegen und Erwartungen der Patientin/des Patienten: _____

1 Ihre Erkrankung und das Ziel des Eingriffs

Mit zunehmendem Alter verliert die Lidhaut an Elastizität, der Ringmuskel um das Auge erschlafft, und das Fettgewebe der Augenhöhle kann sich nach vorne wölben. Dadurch entsteht an den Oberlidern **überschüssige, herabhängende Haut** und unter den Augen bilden sich **Tränensäcke und Augenringe (Vertiefungen)**. Erbliche Veranlagung, Sonneneinstrahlung, Rauchen und Gewichtsschwankungen können diesen Prozess beschleunigen.

Die Blepharoplastik zielt darauf ab, der Augenpartie durch Entfernung überschüssiger Haut, Muskulatur und Fettgewebe oder durch Umverlagerung von Fett ein **frischeres, erholteres und natürliches** Aussehen zu verleihen. Ein Überhang der Oberlider kann manchmal so ausgeprägt sein, dass er den oberen Teil des Gesichtsfeldes einschränkt; in diesem Fall hat die Operation zusätzlich den funktionellen Zweck, **das Gesichtsfeld zu erweitern**.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Eine Blepharoplastik allein korrigiert keine tief stehenden Augenbrauen, kein herabhängendes Oberlid infolge einer Schwäche des Lidhebermuskels (Ptosis), keine feinen Fältchen (Krähenfüße) und keine dunklen Augenringe; hierfür können andere Behandlungen erforderlich sein.

2 Wie wird der Eingriff durchgeführt?

Vor der Operation werden Ihre Augen untersucht – Sehvermögen, Tränenproduktion und Lidfunktion werden beurteilt – und es werden Fotos angefertigt. Falls erforderlich, wird eine augenärztliche Untersuchung veranlasst.

1. **Anzeichnen:** Die zu entfernende Hautmenge wird im Sitzen bei geöffneten und geschlossenen Augen sorgfältig angezeichnet.
2. **Oberlid:** Der Schnitt wird in die natürliche Lidfalte gelegt, sodass er bei geöffneten Augen verborgen in der Falte liegt. Überschüssige Haut sowie bei Bedarf ein schmaler Muskelstreifen und vorgewölbtes Fettgewebe werden entfernt.
3. **Unterlid – transkonjunktivale Technik:** Der Schnitt wird an der Innenseite des Augenlids gesetzt, sodass außen keine Narbe sichtbar ist. Das Fett, das die Tränensäcke verursacht, wird entfernt oder so umverlagert, dass es die Vertiefung unter dem Auge auffüllt.
4. **Unterlid – subziliare Technik:** Besteht zusätzlich überschüssige Haut, wird der Schnitt direkt unterhalb der Wimpern gesetzt, und überschüssige Haut und Muskulatur werden entfernt. Die Narbe wird mit der Zeit meist unauffällig.
5. **Lidstützung (Kanthopexie/Kanthoplastik):** Ist das Unterlid erschlafft, werden am äußeren Augenwinkel Stützнähte gesetzt, um zu verhindern, dass das Lid nach der Operation nach unten gezogen wird.
6. **Wundverschluss:** Die Schnitte werden mit sehr feinen Nähten verschlossen, die in der Regel am **5.–7. Tag** gezogen werden. Auf das Auge wird eine schützende Salbe aufgetragen.

BETÄUBUNG (ANÄSTHESIE)	VORAUSSICHTLICHE DAUER	KRANKENHAUSAUFENTHALT / ENTLASSUNG
Örtliche Betäubung (± Dämmerschlaf/ Sedierung) oder Vollnarkose	Etwa 1–3 Stunden	In der Regel Entlassung am selben Tag; nach Vollnarkose kann eine Nacht erforderlich sein

3 Erwarteter Nutzen und Erfolgsaussichten

- Eine frischere, erholtere und jünger wirkende Augenpartie
- Weniger Schweregefühl der Oberlider; leichteres Sehen, wenn der Überhang das Gesichtsfeld einschränkt
- Kleinere Tränensäcke und ein glatterer Übergang unter dem Auge

Die meisten Patienten sind mit dem Ergebnis zufrieden, und die Wirkung hält in der Regel viele Jahre an; da der Alterungsprozess jedoch weitergeht, kann die Haut mit der Zeit wieder erschlaffen. Bei etwa **2–5 von 100** Patienten kann wegen Asymmetrie, Unterkorrektur oder Narbenbildung ein kleiner Korrektureingriff erforderlich sein. Das endgültige Ergebnis zeigt sich in der Regel innerhalb von **3–6 Monaten**.

4 Andere Behandlungsmöglichkeiten

- **Verzicht auf die Operation:** Da es sich um einen ästhetischen Eingriff handelt, haben Sie immer die Möglichkeit, ihn nicht durchführen zu lassen.
- **Filler für die Tränenrinne:** Kann eine leichte Vertiefung unter dem Auge vorübergehend kaschieren; Tränensäcke oder überschüssige Haut werden dadurch nicht korrigiert, und die Behandlung hat eigene spezifische Risiken.
- **Augenbrauenanhebung mit Botulinumtoxin:** In leichten Fällen kann das Anheben der Augenbraue um einige Millimeter das Oberlid etwas öffnen; die Wirkung ist vorübergehend.
- **Brauenlift (Schläfenlift / Stirnlift):** Liegt die eigentliche Ursache in einer tief stehenden Augenbraue, kann dies anstelle einer oder zusätzlich zur Blepharoplastik besser geeignet sein.
- **Hauterneuernde Behandlungen (Laser, chemisches Peeling, Radiofrequenz):** Können feine Fältchen und die Hautqualität verbessern; deutlich überschüssige Haut oder Tränensäcke werden dadurch nicht beseitigt.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

5 Was geschieht, wenn der Eingriff nicht durchgeführt wird?

Ohne Operation bleibt das derzeitige Aussehen Ihrer Augenlider bestehen und kann mit dem Alter langsam zunehmen. Wenn ein Überhang der Oberlider Ihr Gesichtsfeld einschränkt, kann dies mit der Zeit zunehmen; in der Regel besteht jedoch keine akute Gefahr für die Gesundheit der Augen.

Sie haben das Recht, den empfohlenen Eingriff abzulehnen, ihn zu verschieben oder eine ärztliche Zweitmeinung einzuholen. Diese Entscheidung hat keinerlei Einfluss auf andere medizinische Leistungen, die Ihnen angeboten werden. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit vor Beginn des Eingriffs widerrufen; bitte beachten Sie jedoch, dass es nach Beginn eines Eingriffs Phasen geben kann, in denen ein Abbruch medizinisch nicht vertretbar wäre.

6 Vorbereitung auf den Eingriff

- Vor der Operation werden Blutuntersuchungen durchgeführt; ist eine Vollnarkose oder Sedierung geplant, werden Sie von der Narkoseärztin bzw. dem Narkosearzt untersucht und müssen vorher nüchtern bleiben.
- Teilen Sie uns unbedingt mit, wenn Sie **trockene Augen, ein Glaukom (grüner Star), eine Schilddrüsenerkrankung oder frühere Augenoperationen (z. B. Augenlaser zur Korrektur einer Fehlsichtigkeit)** haben.
- Wenn Sie Kontaktlinsen tragen, setzen Sie diese am Operationstag nicht ein; nach der Operation müssen Sie eine Brille tragen.
- Tragen Sie am Operationstag kein Augen-Make-up, keine Wimpernverlängerung und keine Gesichtscreme. Nach Sedierung oder Vollnarkose dürfen Sie nicht selbst Auto fahren; bitte lassen Sie sich von einer Begleitperson nach Hause bringen.
- Teilen Sie Ihrem Arzt **alle Medikamente** mit, die Sie einnehmen (einschließlich Blutverdünnern, Aspirin, Schmerzmitteln, Medikamenten zur Gewichtsabnahme und Hormonpräparaten), sowie alle **pflanzlichen Mittel und Nahrungsergänzungsmittel** (z. B. Omega-3, Vitamin E, Ginkgo, Knoblauch, Ginseng, Fischöl). Setzen Sie kein Medikament eigenmächtig ohne ärztlichen Rat ab.
- Informieren Sie uns unbedingt über **Allergien**, Blutungs- oder Gerinnungsstörungen, Herz- und Lungenerkrankungen, Diabetes, Bluthochdruck oder Schilddrüsenerkrankungen, frühere Operationen sowie über Probleme, die Sie bei früheren Narkosen hatten.
- Wenn Sie möglicherweise schwanger sind oder stillen, teilen Sie uns dies bitte vor dem Eingriff mit.
- Rauchen und Nikotinprodukte beeinträchtigen die Wundheilung erheblich. Hören Sie nach Möglichkeit mindestens 2–4 Wochen vor dem Eingriff damit auf und rauchen Sie während der Heilungsphase nicht.

7 Heilungsverlauf: Was Sie erwartet

Erste 48 Stunden	Um die Augen können Schwellung, Spannungsgefühl, leichtes Nässen und Blutergüsse auftreten. Die Schmerzen sind meist gering. Schlafen mit erhöhtem Kopf und **kalte Kompressen** helfen, die Schwellung zu verringern. Tränende Augen, Lichtempfindlichkeit und vorübergehend verschwommenes Sehen (durch die Salbe) können auftreten.
1. Woche	Die Fäden werden in der Regel am **5.–7. Tag** gezogen. Blutergüsse und Schwellung gehen deutlich zurück. Augentropfen/-salbe werden nach Anweisung angewendet. Die meisten Patienten kehren innerhalb von 7–10 Tagen zur Bürotätigkeit und ins gesellschaftliche Leben zurück; Blutergüsse können mit Make-up abgedeckt werden.
2.–4. Woche	Die verbleibende Schwellung geht zurück. Kontaktlinsen können in der Regel nach **2 Wochen** wieder getragen werden. Anstrengender Sport und Tätigkeiten mit Bücken sollten etwa 2–3 Wochen aufgeschoben werden. Warten Sie vor dem Schwimmen oder dem Tragen von Augen-Make-up die Freigabe durch Ihre Ärztin bzw. Ihren Arzt ab.
1.–6. Monat	Die Rötung der Narbe verblasst allmählich, und die Narbe ist in der Lidfalte kaum noch zu sehen. Die endgültige Form und Symmetrie der Lider stellen sich in der Regel innerhalb von **3–6 Monaten** ein.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

8 Mögliche Risiken und Komplikationen

Wie jeder medizinische Eingriff ist auch dieser Eingriff mit gewissen Risiken verbunden. Im Folgenden sind **zu erwartende vorübergehende Begleiterscheinungen** und **Komplikationen** getrennt aufgeführt und nach ihrer Häufigkeit geordnet. Die angegebenen Zahlen sind **ungefähre** Werte aus der medizinischen Fachliteratur; Ihr persönliches Risiko kann je nach Alter, allgemeinem Gesundheitszustand, Rauchen und früheren Operationen niedriger oder höher sein.

Die allermeisten Komplikationen sind **vorübergehend** und bessern sich bei angemessener Behandlung. Aufgeführt sind auch sehr seltene, aber schwerwiegende Ereignisse; dass sie hier stehen, bedeutet nicht, dass sie bei Ihnen auftreten werden, doch Sie sollten sie kennen, um eine informierte Entscheidung treffen zu können.

Zu erwartende, vorübergehende Begleiterscheinungen (keine Komplikationen – ein normaler Teil der Heilung)

- Schwellung und Spannungsgefühl um die Augen; Blutergüsse klingen, **falls sie auftreten**, innerhalb von 1–2 Wochen ab
- Tränende Augen, Trockenheits- oder Fremdkörpergefühl, Stechen und Lichtempfindlichkeit (erste Tage)
- Leichte Schwierigkeiten, die Augen in den ersten Tagen vollständig zu schließen
- Rötung, leichte Verhärtung und Taubheitsgefühl entlang des Schnitts

Häufige Beschwerden (meist vorübergehend oder mit Behandlung rückläufig)

- **Trockenes Auge** — Etwa **10–25 von 100** Patienten haben ein stechendes, brennendes oder trockenes Gefühl; es bessert sich meist mit Augentropfen innerhalb weniger Wochen bis einiger Monate. Bei Menschen, die bereits trockene Augen haben, kann es ausgeprägter sein und länger anhalten.
- **Schwellung der Bindehaut über dem Augenweiß (Chemosis)** — Flüssigkeitsbedingte Schwellung der Haut, die das Weiße des Auges bedeckt; tritt vor allem nach Unterlidoperationen auf. Sie bildet sich in der Regel mit Tropfen und Kompressen innerhalb weniger Wochen zurück.
- **Unvollständiger Lidschluss (Lagophthalmus)** — Ein unvollständiger Lidschluss im Schlaf ist in den ersten Wochen nach einer Oberlidoperation häufig und bildet sich meist von selbst zurück. In dieser Zeit wird zum Schutz des Auges eine Salbe für die Nacht empfohlen. Selten bleibt er dauerhaft bestehen (**weniger als 1 von 100**).
- **Kleine Zysten (Milien) und Stichkanalnarben** — Entlang des Schnitts können sich kleine weiße Pünktchen bilden; sie verschwinden von selbst oder werden mit einem einfachen Eingriff entfernt.

Gelegentliche Beschwerden

- **Herabgezogenes oder nach außen gedrehtes Unterlid (Lidretraktion, Ektropium)** — Nach einer Unterlidoperation kann bei etwa **1–5 von 100** Patienten (häufiger bei der subziliaren Technik) das Unterlid nach unten gezogen sein, unterhalb der Iris mehr vom Weißen des Auges sichtbar werden oder sich das Lid nach außen drehen. Die meisten Fälle bessern sich mit Massage und Tape-Verbänden; bleibt der Zustand bestehen, kann er zu trockenen und tränenden Augen führen, und eine **Korrekturoperation** kann erforderlich sein.
- **Asymmetrie sowie Unter- oder Überkorrektur** — Zwischen beiden Augenlidern können Unterschiede in Höhe oder Form der Lidfalte bestehen bleiben; wird zu viel Haut entfernt, kann der Lidschluss erschwert sein, und wird zu viel Fett entfernt, kann ein eingefallenes Aussehen entstehen. Ein Korrektureingriff kann erforderlich sein.
- **Veränderung der Form des Augenwinkels** — Wenn eine Lidstützung (Kanthopexie/Kanthoplastik) durchgeführt wird, kann der äußere Augenwinkel eine Zeit lang straff, nach oben gezogen oder abgerundet wirken oder sich zwischen beiden Seiten unterscheiden. Meist gleicht sich dies im Laufe einiger Wochen bis Monate mit dem Abklingen der Schwellung aus; selten ist eine Korrektur nötig.
- **Sichtbarwerden eines hängenden Oberlids (Ptosis)** — Eine Schwäche des Lidhebermuskels, die zuvor durch die überschüssige Haut verdeckt war, kann nach der Operation sichtbar werden; sie muss gegebenenfalls in einer gesonderten Operation korrigiert werden.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Auffällige oder verdickte Narbe** — Lidhaut heilt in der Regel sehr gut; selten kann die Narbe sichtbar bleiben oder sich am inneren Augenwinkel eine feine Hautfalte (Narbensegel, „Webbing“) bilden.
- **Nachblutung und Blutansammlung (Hämatom)** — Eine Blutansammlung unter der Haut tritt bei etwa **1 von 100** Patienten auf; sie bildet sich meist von selbst zurück, muss aber bei größerem Ausmaß unter Umständen entleert werden.
- **Infektion** — Da die Augenlider sehr gut durchblutet sind, sind Infektionen selten (**weniger als 1 von 100**); tritt eine Infektion auf, wird sie mit Antibiotika behandelt.

Seltene oder sehr seltene, aber möglicherweise schwerwiegende Komplikationen

- **Blutung hinter dem Auge und Sehverlust** — Dies ist die schwerwiegendste, aber sehr seltene Komplikation. Eine Blutung hinter dem Auge tritt bei etwa **1 von 2.000** Patienten auf und kann auf den Sehnerv drücken. Wird sie nicht rasch erkannt und als Notfall behandelt (Öffnen der Nähte, Entleeren des Blutes, Medikamente, Notoperation), kann sie zu einem **dauerhaften Sehverlust** führen. Ein dauerhafter Sehverlust wurde bei etwa **1 von 10.000–40.000** Patienten oder seltener beschrieben. Deshalb sind die Warnzeichen in den ersten 48 Stunden so wichtig.
- **Doppelbilder** — Entstehen durch eine Beeinträchtigung eines kleinen Augenmuskels (Musculus obliquus inferior) bei einer Unterlidoperation; sie sind meist vorübergehend, sehr selten dauerhaft und können eine weitere Behandlung oder Operation erfordern.
- **Hornhautkratzer oder Hornhautgeschwür** — Auf der durchsichtigen vorderen Augenoberfläche kann ein Kratzer entstehen, der Schmerzen, ein Fremdkörpergefühl und Tränen verursacht; er heilt meist mit Tropfen innerhalb weniger Tage ab. Sehr selten kann eine längerfristige augenärztliche Behandlung erforderlich sein.
- **Störungen des Tränenabflusses** — Tränende Augen infolge einer Beeinträchtigung der Tränenwege sind sehr selten.
- **Psychische Unzufriedenheit** — Trotz eines technisch erfolgreichen Ergebnisses kann es einem Menschen schwerfallen, sich an sein neues Aussehen zu gewöhnen. Ein offenes Gespräch über die Erwartungen vor der Operation verringert dieses Risiko.

Allgemeine Risiken jedes operativen / medizinischen Eingriffs

- **Narkoserisiken:** Wird eine Vollnarkose oder Sedierung (Dämmerschlaf) durchgeführt, erläutert Ihnen der Narkosearzt deren Risiken (Übelkeit, Halsschmerzen, Zahnschäden, allergische Reaktion und sehr selten Herz- oder Lungenprobleme) gesondert, und Ihre Einwilligung wird auf einem **separaten Narkose-Aufklärungsbogen** eingeholt.
- **Blutung und Bluttransfusion:** Eine Bluttransfusion ist bei diesen Eingriffen nur sehr selten erforderlich. Bei einer schweren Blutung können Blut oder Blutprodukte notwendig werden; diese bergen eigene, sehr seltene Risiken (z. B. Allergie oder Infektion).
- **Infektion:** Eine Wundinfektion nach der Operation wird in der Regel mit Antibiotika behandelt; selten kann eine Drainage (Ableiten des Eiters) notwendig sein.
- **Blutgerinnsel in den Beinvenen (Thrombose) und in der Lunge (Lungenembolie):** Bei kurzen Operationen im Kopf-Hals-Bereich sehr selten. Frühes Aufstehen und Gehen senkt das Risiko. Hormonpräparate, Rauchen, starkes Übergewicht und frühere Blutgerinnsel erhöhen das Risiko.
- **Medikamentenallergie:** Auf die verwendeten Medikamente, Desinfektionsmittel, Pflaster oder Nahtmaterialien kann eine allergische Reaktion auftreten.
- **Narbenbildung und Heilungsstörungen:** Wie Narben verheilen, ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich; sehr selten kann sich eine verdickte (hypertrophe) Narbe oder ein Keloid bilden.
- **Lebensgefahr:** Todesfälle bei geplanten Operationen im Kopf-Hals-Bereich sind heute äußerst selten; dennoch ist kein operativer Eingriff völlig frei von Risiken. Eine schwere Komplikation kann eine Behandlung auf der Intensivstation erforderlich machen und zu einer bleibenden Behinderung führen.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Diese Aufstellung umfasst nicht jede denkbare Komplikation; andere unvorhersehbare und sehr seltene Ereignisse können auftreten. Tritt eine Komplikation auf, plant Ihr Arzt die notwendige Behandlung und Nachsorge; dies kann eine zusätzliche Behandlung, Medikamente, Eingriffe oder eine erneute Operation erfordern.

9 Wann Sie sich sofort bei uns melden sollten

- **Starke, zunehmende Schmerzen im Auge**, besonders auf einer Seite
- **Hervortreten des Auges** oder rasch zunehmende, pralle Schwellung und Blutergüsse der Augenlider
- **Nachlassendes Sehvermögen**, Verdunkelung des Sehens, Doppelbilder oder eingeschränkte Augenbeweglichkeit
- Augenschmerzen zusammen mit Übelkeit oder Erbrechen
- **Fieber über 38,5 °C**, zunehmende Rötung, Absonderung oder Schmerzen am Schnitt
- Ausgeprägte Lichtempfindlichkeit und ein Fremdkörpergefühl, das nicht vergeht
- **Wenn eines dieser Zeichen in den ersten 48 Stunden auftritt, zählt jede Minute: Rufen Sie sofort an oder suchen Sie die nächstgelegene Notaufnahme auf.**

Wenn eines dieser Anzeichen auftritt, rufen Sie unverzüglich Ihren Arzt an: +90 288 502 50 20 · WhatsApp +90 555 333 21 20. Wenn Sie uns nicht erreichen, suchen Sie die nächste Notaufnahme auf oder wählen Sie die 112 (Notrufnummer in der Türkei und in ganz Europa).

10 Hinweise zu Medikamenten und zum Alltag

- Legen Sie in den ersten 48 Stunden in regelmäßigen Abständen kalte Kompressen auf; schlafen Sie auf dem Rücken mit erhöhtem Kopf.
- Reiben Sie sich nicht die Augen. Vermeiden Sie in den ersten Tagen schweres Heben, Bücken, Pressen und Aktivitäten, die das Blutungsrisiko erhöhen.
- Wenden Sie die Ihnen gegebenen Augentropfen und Salben so oft wie empfohlen an; wenn sich Ihre Augen nicht vollständig schließen, tragen Sie die Salbe für die Nacht unbedingt auf.
- In der Regel sollten Sie 2 Wochen lang keine Kontaktlinsen und 1–2 Wochen lang kein Augen-Make-up tragen. Tragen Sie im Freien eine Sonnenbrille und legen Sie bei der Bildschirmarbeit häufig Pausen ein.
- Wenn Sie aus dem Ausland angereist sind, ist eine Flugreise in der Regel nach dem Ziehen der Fäden (5.–7. Tag) unbedenklich.
- Nehmen Sie die Ihnen verordneten Medikamente (Antibiotika, Schmerzmittel usw.) in der empfohlenen Dosierung und für die empfohlene Dauer ein. Nehmen Sie Aspirin oder ähnliche Medikamente, die Blutungen verstärken können, nicht ohne Rücksprache mit Ihrem Arzt ein.
- Trinken Sie nach der Operation bei Flügen oder Reisen von mehr als 4 Stunden reichlich Wasser, bewegen Sie sich regelmäßig und tragen Sie, falls empfohlen, Kompressionsstrümpfe; dies senkt das Risiko von Blutgerinnseln in den Beinen.
- Während der Heilungsphase wird empfohlen, keinen Alkohol zu trinken und auf Rauchen und Nikotinprodukte zu verzichten.
- Bitte nehmen Sie alle Kontrolltermine wahr. Wenn Sie aus dem Ausland angereist sind, kann die Nachsorge nach Ihrer Rückkehr per Online-Sprechstunde und Fotos/Videos fortgeführt werden; falls Sie einen Arzt vor Ort aufsuchen müssen, erhalten Sie einen schriftlichen Operationsbericht und unsere Empfehlungen.

11 Unerwartete Befunde während des Eingriffs, Gewebeproben und Blutprodukte

Ergibt sich während des Eingriffs eine unvorhergesehene Situation, hält sich Ihr Arzt an den Umfang des Eingriffs, in den Sie mit diesem Bogen eingewilligt haben. **Sofern keine Lebensgefahr und keine Gefahr eines schweren Organschadens besteht**, wird kein zusätzlicher Eingriff vorgenommen, in den Sie nicht eingewilligt haben; in diesem Fall wird der Eingriff an einem sicheren Punkt beendet, und Sie werden anschließend informiert, damit die

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Entscheidung gemeinsam mit Ihnen getroffen werden kann. Besteht Lebensgefahr, wird die Notfallbehandlung durchgeführt, die zum Schutz Ihres Lebens oder des Organs erforderlich ist.

Während des Eingriffs entnommenes Gewebe wird, wenn nötig, zur Sicherung der Diagnose zur **feingeweblichen (pathologischen) Untersuchung** eingesandt. Je nach Ergebnis kann eine weitere Behandlung oder Nachsorge erforderlich sein.

Eine Bluttransfusion ist bei diesen Eingriffen nur sehr selten notwendig und wird nur verabreicht, wenn sie lebenswichtig ist. Wenn Sie Blut oder Blutprodukte ablehnen (zum Beispiel aus religiösen Gründen), müssen Sie uns dies vor dem Eingriff mitteilen; die möglichen Folgen dieser Entscheidung werden gesondert mit Ihnen besprochen und unter „Informationen speziell für Sie“ festgehalten.

12 Fotos, Bildaufnahmen und Ihre personenbezogenen Daten

Vor und nach dem Eingriff können zur Planung, Verlaufskontrolle und Beurteilung des Ergebnisses **Fotos/Videos** angefertigt werden. Diese Aufnahmen sind Teil Ihrer Krankenakte und werden vertraulich behandelt. Ihre Aufnahmen werden **niemals für Werbung, Öffentlichkeitsarbeit oder soziale Medien verwendet.**

Für jeden anderen Zweck dürfen Ihre Aufnahmen **nur mit Ihrer gesonderten und ausdrücklichen Erlaubnis** verwendet werden. Eine Ablehnung hat keinerlei Einfluss auf Ihre Behandlung, und Sie können Ihre Erlaubnis jederzeit widerrufen:

- ☐ Ich bin damit einverstanden, dass meine Aufnahmen **ausschließlich für die medizinische Dokumentation und die Verlaufskontrolle der Behandlung** verwendet werden.
- ☐ Ich erlaube die Verwendung meiner Aufnahmen für wissenschaftliche Veröffentlichungen und die ärztliche Aus- und Weiterbildung **in einer Form, in der ich nicht erkennbar bin** (Gesicht/Augenpartie abgedeckt).
- ☐ Ich erlaube die Verwendung meiner Aufnahmen für wissenschaftliche Veröffentlichungen und die ärztliche Aus- und Weiterbildung **in einer Form, in der ich erkennbar sein kann**.
- ☐ Ich **erlaube keine** Verwendung zu wissenschaftlichen Zwecken / Ausbildungszwecken.

Ihre personenbezogenen Daten und Gesundheitsdaten werden nach dem türkischen Gesetz Nr. 6698 zum Schutz personenbezogener Daten (KVKK) und den einschlägigen gesundheitsrechtlichen Vorschriften zu Zwecken der Diagnose, der Behandlung und der Erfüllung gesetzlicher Pflichten von Personen verarbeitet, die der beruflichen Schweigepflicht unterliegen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte unseren Datenschutzhinweisen.

13 Informationen und Anmerkungen speziell für Sie (vom Arzt auszufüllen)

Patientenspezifische zusätzliche Risiken (Begleiterkrankungen, Medikamente, frühere Operationen), Einzelheiten der Planung, Erwartungen der Patientin / des Patienten, gestellte Fragen und gegebene Antworten. Gibt es nichts zu ergänzen, „keine“ eintragen.

14 Erklärung der Patientin / des Patienten

- ☐ Ich habe diesen Bogen in meiner Sprache gelesen und verstanden. Ich hatte ausreichend Bedenkzeit, konnte Fragen stellen und habe zufriedenstellende Antworten erhalten.
- ☐ Meine Erkrankung, das Ziel des empfohlenen Eingriffs, wie, von wem und wo er durchgeführt wird, seine voraussichtliche Dauer, der erwartete Nutzen, die Erfolgsaussichten, die Alternativen und die möglichen Folgen, wenn er nicht durchgeführt wird, wurden mir mündlich und schriftlich erklärt.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- ☐ Die häufigen und die möglicherweise schwerwiegenden Risiken sowie die möglichen Folgen dieser Komplikationen (einschließlich der Möglichkeit, dass eine weitere Behandlung oder ein erneuter Eingriff bzw. eine erneute Operation notwendig wird) wurden mir erklärt. Mir ist bewusst, dass das Ergebnis eines medizinischen Eingriffs **nicht zu 100 % garantiert werden kann**.
- ☐ Ich habe zutreffende und vollständige Angaben zu meinem Gesundheitszustand, meinen Medikamenten, meinen Allergien und früheren Erkrankungen gemacht. Mir ist bewusst, dass unvollständige oder falsche Angaben die Risiken erhöhen können.
- ☐ Mir ist bewusst, dass die Befolgung der Anweisungen vor und nach dem Eingriff zum Ergebnis beiträgt und dass die Wahrnehmung der Kontrolltermine wichtig ist.
- ☐ Ich weiß, dass ich meine Einwilligung jederzeit vor Beginn des Eingriffs widerrufen kann. Mir ist bewusst, dass meine Unterschrift unter diesen Bogen den Arzt nicht von seiner Sorgfaltspflicht entbindet.
- ☐ Ich treffe diese Entscheidung aus freiem Willen und ohne Druck von irgendeiner Seite.
- ☐ Ich habe verstanden, dass eine Blepharoplastik allein keine tief stehenden Augenbrauen, kein herabhängendes Oberlid infolge einer Schwäche des Lidhebermuskels, keine feinen Fältchen und keine dunkle Verfärbung unter den Augen korrigiert.
- ☐ Ich habe verstanden, dass ich **sofort** ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen muss, wenn in den ersten 48 Stunden nach der Operation starke Augenschmerzen, eine Schwellung oder ein nachlassendes Sehvermögen auftreten.
- ☐ Mir ist bewusst, dass dieser Eingriff **ästhetischer Natur** ist, dass er medizinisch nicht notwendig ist und dass ich jederzeit die Möglichkeit habe, ihn nicht durchführen zu lassen. Ich habe meine Erwartungen mit meinem Arzt besprochen, und das realistisch erreichbare Ergebnis wurde mir erklärt.
- ☐ Mir ist bewusst, dass weder eine vollkommene Symmetrie noch eine exakte Nachbildung des Aussehens auf einem Foto garantiert werden kann, dass das endgültige Ergebnis davon abhängt, wie mein Gewebe heilt, und dass in manchen Fällen ein Korrektureingriff notwendig sein kann.

- ☐ **Ich ERTEILE MEINE EINWILLIGUNG zu dem oben beschriebenen Eingriff.**
- ☐ **Den oben beschriebenen Eingriff LEHNE ICH AB. Die möglichen Folgen der Ablehnung wurden mir erklärt.**

Wir empfehlen, dass die Patientin / der Patient handschriftlich ergänzt: „Ich habe diesen Bogen gelesen und verstanden und willige ein."

15 Unterschriften

	VOR- UND NACHNAME	UNTERSCHRIFT	DATUM / UHRZEIT
Patient/in			
Gesetzliche/r Vertreter/in (Elternteil / Vormund) – Verhältnis zum Patienten:			
Aufklärender und durchführender Arzt			
Dolmetscher/in (falls erforderlich) – Sprache:			
Zeuge/Zeugin (falls erforderlich)			

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Erklärung der Dolmetscherin / des Dolmetschers: Ich habe diesen Bogen und die mündlichen Erläuterungen des Arztes der Patientin / dem Patienten bzw. der gesetzlichen Vertretung vollständig und korrekt in eine für sie verständliche Sprache übersetzt.

FÜR PATIENTINNEN UND PATIENTEN UNTER 18 JAHREN ODER MIT EINGESCHRÄNKTER EINWILLIGUNGSFÄHIGKEIT

Bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren wird die Einwilligung von einem **Elternteil oder dem gesetzlichen Vormund** erteilt. Das Kind wird seinem Alter und seiner Reife entsprechend aufgeklärt, und seine Meinung wird eingeholt. Bei nicht einwilligungsfähigen Patientinnen und Patienten erteilt die gesetzliche Vertretung die Einwilligung.

☐ Sofern wir das Sorgerecht gemeinsam ausüben, erkläre ich, dass der andere Elternteil über diesen Eingriff informiert ist und ihm zustimmt.

☐ Ich erkläre, dass keine gerichtliche Entscheidung und kein Streit über das Sorgerecht / die Vormundschaft besteht (falls doch, wurde dem Arzt das entsprechende Dokument vorgelegt).

Das Kind wurde altersgerecht aufgeklärt; Meinung des Kindes: _____

Dieser Bogen wurde in zwei Exemplaren ausgefertigt: Ein Exemplar verbleibt in der Patientenakte, eines erhält die Patientin / der Patient bzw. die gesetzliche Vertretung.

WIDERRUF DER EINWILLIGUNG (NUR AUSFÜLLEN, WENN SIE SICH ANDERS ENTSCHEIDEN)

Ich widerrufe die oben erteilte Einwilligung. Die möglichen Folgen des Widerrufs wurden mir erklärt.

Name, Unterschrift, Datum und Uhrzeit der widerrufenden Person (Patient/in bzw. Vertreter/in): _____

Dieser Bogen wurde in Übereinstimmung mit der türkischen Patientenrechteverordnung und den Grundsätzen der Türkischen Ärztekammer zur Aufklärung und Einwilligung erstellt. Er ergänzt das mündliche Aufklärungsgespräch mit Ihrem Arzt, ersetzt es aber nicht.